Processo nº **0018199-62.2025.8.17.2001**

AUTOR(A): TANIA DE SOUSA AZOUBEL

RÉU: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

SENTENÇA – extinção com resolução do mérito

Vistos etc.

Tem a presente "AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS" promovida por TANIA DE SOUSA AZOUBEL GALINDO em face da UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL e UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, todos devidamente qualificados, o fim de compelir os requeridos a fornecerem a medicação Prolia (denosumabe) 60mg/mL (solução injetável subcutânea), semestralmente, medicamento esse que vem sendo negado pelos planos requeridos.

Diz a autora, em apartada síntese, que foi diagnosticada com quadro de osteopenia e, caso não tratada, poderia evoluir para quadro de osteoporose.

Diz que ao fazer a solicitação do fornecimento aos planos requeridos, estes negaram, tacitamente, o fornecimento uma vez que não deram respostas à solicitante dos seus requerimentos.

Requereu fosse deferida a tutela de urgência a fim de compelir os Requeridos a custearem o medicamento como prescrito, e no mérito a confirmação da tutela e a condenação em danos morais.

Instruiu a Exordial com os documentos de ID's n. 196461138 a 196461150.

Concedida a tutela de urgência (Decisão ID 196595266).

Posteriormente, as Demandadas deduziram suas defesas nos ids. 199218051 e 199465521, acrescido de documentos.

Réplica no id. 204209557.

Os autos me foram apresentados.

É o que importa relatar. Passo à decisão.

Inicialmente, pontue-se que a demanda em tela comporta julgamento antecipado (*julgamento conforme o estado do processo*), posto que, embora envolva matéria fática, entendo que não há necessidade de produção de provas outras além das que já foram produzidas (*art. 330, I, do Código de Processo Civil*).

Compulsando o compêndio processual, afere-se que a parte demandante submeteu ao crivo deste juízo a presente demanda com o fito de que o Plano de Saúde Requerido seja compelido a lhe fornecer o fármaco prescrito pela profissional que o assiste, *in casu* Prolia (denosumabe) 60mg/mL (solução injetável subcutânea), a ser aplicada em periodicidade semestral (de modo contínuo e por tempo indeterminado), conforme Laudo (ID 196461144) e prescrição ID 196461145), subscrito pela Dra.Juliana Schettini, indispensável para o tratamento de sua enfermidade.

Visando subsidiar o seu intento, trouxe à colação os elementos de ID 196461138 a 196461150.

Consoante outrora asseverado, as demandadas, devidamente citadas para angularizar a relação processual, deduziram as contestações de ids. 199218051 e 199465521.

A UNIMED RECIFE (id. 199218051), apresentou preliminar de ilegitimidade passiva, aduzindo que inexiste relação contratual entre ela e a parte Autora, competindo a responsabilidade apenas à UNIMED NACIONAL, por se tratar de pessoas jurídicas distintas. No mais defende a inocorrência de danos morais, e pede a improcedência da ação.

A UNIMED NACIONAL (ID. 199465521), no mérito, em síntese, pugnou pela improcedência dos pedidos autorais, alegando, para tanto, que a cobertura pretendida pela autora, consistente no fornecimento de medicamento não foi incorporado pela ANS para cobertura obrigatória, além de haver exclusão contratual, motivo pelo qual foi negada a autorização.

Pugna pela taxatividade do rol da ANS. Argumenta a não ocorrência de danos morais, e pede a improcedência da ação.

Da preliminar de ilegitimidade avençada pela Unimed Recife.

Entendo que a Unimed Recife e a UNIMED NACIONAL, integram o sistema Nacional Unimed que, por sua vez consiste em um sistema integrado de planos de saúde.

Destarte, torna-se ineficaz a alegação de ilegitimidade, com este fundamento.

Tal é o entendimento jurisprudencial sobre a questão:

> "RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. USUÁRIO EM INTERCÂMBIO. UNIMED EXECUTORA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. UNIMED DE ORIGEM. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. REDE INTERLIGADA. MARCA ÚNICA. ABRANGÊNCIA NACIONAL. TEORIA DA APARÊNCIA. CADEIA DE FORNECEDORES. CDC. INCIDÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se a cooperativa de trabalho médico que atendeu, por meio do sistema de intercâmbio, usuário de plano de saúde de cooperativa de outra localidade possui legitimidade passiva ad causam na hipótese de negativa indevida de cobertura. 2. Apesar de os planos e seguros privados de assistência à saúde serem regidos pela Lei nº 9.656/1998, as operadoras da área que prestarem serviços remunerados à população enquadram-se no conceito de fornecedor, existindo, pois, relação de consumo, devendo ser aplicadas também, nesses tipos contratuais, as regras do Código de Defesa do Consumidor (art. 35-G da Lei nº 9.656/1998 e Súmula nº 469/STJ). 3. O Complexo Unimed do Brasil é constituído sob um sistema de cooperativas de saúde, independentes entre si e que se comunicam através de um regime de intercâmbio, o que possibilita o atendimento de usuários de um plano de saúde de dada unidade em outras localidades, ficando a Unimed de origem responsável pelo ressarcimento dos serviços prestados pela Unimed executora. Cada ente é autônomo, mas todos são interligados e se apresentam ao consumidor sob a mesma marca, com abrangência em todo território nacional, o que constitui um fator de atração de novos usuários. 4. Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência). Precedente da Quarta Turma. 5. É transmitido ao consumidor a imagem de que o Sistema Unimed garante o

atendimento à saúde em todo o território nacional, haja vista a integração existente entre as cooperativas de trabalho médico, a gerar forte confusão no momento da utilização do plano de saúde, não podendo ser exigido dele que conheça pormenorizadamente a organização interna de tal complexo e de suas unidades. 6. Tanto a Unimed de origem quanto a Unimed executora possuem legitimidade passiva ad causam na demanda oriunda de recusa injustificada de cobertura de plano de saúde. 7. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1665698 CE 2016/0153303-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 23/05/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2017)

Agravo de Instrumento n. 0015744-55.2020.8.17.9000* Agravante: Sherley Pimenta de Lima Agravada: Unimed Norte Nordeste – Confederação das Sociedades Cooperativas de Trabalho Médico Relator: Des. Eduardo Sertório Canto EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE. SOLIDARIEDADE ENTRE AS UNIMEDS. TEORIA DA APARÊNCIA. LEGITIMIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. INCLUSÃO DA UNIMED RECIFE. DADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Trata-se, na origem, de ação ordinária de revisão de reajuste de plano de saúde, proposta em face da Unimed Norte Nordeste. Diante do reiterado descumprimento da decisão liminar e dos cancelamentos unilaterais, a parte autora requereu a inclusão da Unimed Recife no polo passivo da ação. 2. O entendimento do STJ reconhece a responsabilidade solidária das UNIMEDs, pois constituem entidade única, subdividida em diversas outras, sendo, portanto, provenientes do mesmo grupo econômico. 3. Deve a Unimed Recife deve ser incluída na lide para responder, solidariamente, com a Unimed Norte/Nordeste, diante da teoria da aparência. 4. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada, em razão da responsabilidade solidária entre as empresas do mesmo grupo econômico. 5. Dado provimento ao recurso. ACÓRDÃO: Vistos, examinados, discutidos e votados estes autos do Agravo de Instrumento n.0015744-55.2020.8.17.9000, em que figuram como partes as acima indicadas, ACORDAM os Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça que compõem a 3ª Câmara Cível, unanimemente, em DAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório, do voto e da ementa e notas taquigráficas que integram o presente julgado. Recife, data da certificação digital. EDUARDO SERTÓRIO CANTO Desembargador Relator _

(TJ-PE - AI: 00157445520208179000, Relator: FRANCISCO EDUARDO GONCALVES SERTORIO CANTO, Data de Julgamento: 28/02/2023, Gabinete do Des. Francisco Eduardo Gonçalves Sertório Canto)

Desse modo, considero que todas as Rés têm responsabilidade solidária frente ao consumidor, e por isso rejeito a pretensão defensiva no que tange a ilegitimidade ad causam passiva.

No mérito.

De início destaco que a relação existente é de consumo, consoante entendimento sufragado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula 608, que diz: *"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão"*.

Analisando o álbum processual, afere-se que a parte demandante submeteu ao crivo deste Juízo o presente feito com o fito de compelir os Planos de Saúde Requeridos a fornecerem à mesma determinada medicação, mais especificamente Prolia (**DENOSUMABE**) 60mg/ml (solução injetável subcutânea), a ser aplicada em periodicidade semestral***, por prazo indeterminado.***

Compulsando o compêndio processual, afere-se que a demandante, é portadora de enfermidade, qual seja, osteopenia, que pode se agravar à osteoporose (CID M65) e submeteu ao crivo deste juízo a presente demanda, em face das requeridas pelo fato terem se negado a custear, mesmo mantendo relação contratual com os planos requeridos o fármaco DENOSUMABE, consoante prescrição médica – ID n. 196461144, necessário para o tratamento de sua enfermidade.

Visando subsidiar os argumentos expendidos na peça atrial, trouxe à baila os elementos de ID's nº 196461138 a 196461150.

Há que se por em evidência o Laudo de ID 196461144, subscrito pela ginecologista/obstetra Dra. Juliana Schettini CRM 13049-PE – RQE 9101 que, analisando o grave quadro clínico da requerente, prescreveu a medicação ora almejada, **PROLIA** (**DENOSUMABE**) 60mg/ml (solução injetável subcutânea), a ser aplicada em periodicidade semestral***, por prazo indeterminado***.

Mesmo assim, observo que a recusa da Ré com base em ausência de cobertura obrigatória no rol da ANS e exclusão contratual, não deve prevalecer.

A recusa da demandada destoa da finalidade do contrato, relacionado com a saúde e, portanto, com a própria vida, direitos que integram os "direitos fundamentais" protegidos pela Constituição Federal.

O tratamento a ser desenvolvido, exames e a técnica utilizada devem ser discutidos pelo médico e paciente sem a interferência do convênio médico, desde que respeitados os limites previstos no contrato e a utilização de medicamentos devidamente aprovados pela Anvisa e recomendados pela Agência Nacional de Saúde.

No caso dos autos, os réus não juntaram documento capaz de comprovar a ausência de aprovação do medicamento pelas autoridades brasileiras. Ao contrário, apenas justificam a sua recusa pelo fato de não ser obrigatório.

Ocorre que a ausência de obrigatoriedade não é causa suficiente para a recusa na medida em que compete ao réu arcar com os valores destinados ao diagnóstico e tratamento, desde que devidamente liberados pela Agência Nacional de Saúde, tal como ocorre no caso.

No que concerne a ausência de cobertura do rol da ANS, impende ressaltar que o rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) caracteriza listagem de cobertura mínima obrigatória para os planos de saúde, ou seja, caso o tratamento da parte autora não se enquadre exatamente nas hipóteses previstas naquele rol, tal não configura óbice do seu custeio pelas operadoras de plano de saúde.

Em consonância com este entendimento, uníssono no STJ, foi publicada a Lei nº 14.454/2022 que adicionou os §§ 12 e 13 ao art. 10 da Lei nº 9.656/1998, onde reafirmam o caráter exemplificativo do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. Vejamos:

> Art. 10. (...)
>
> § 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. (Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)
>
> § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: (Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)
>
> I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou (Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)

> II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. (Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)

Assim, observa-se que se admite a desconsideração do rol taxativo em situações específicas, a exemplo de inexistir substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS.

Ressalte-se ainda que o fármaco pretendido tem registro na ANVISA, tendo sido prescrito por médico especialista e que a ré, por outro lado, não se desincumbiu de demonstrar a existência de medicamento alternativo apto a trazer os mesmos benefícios ao paciente.

O STJ já se manifestou diversas vezes no sentido de poder o contrato de seguro saúde limitar as doenças a serem cobertas, mas não o tipo de tratamento necessário para cada uma delas.

Nesse sentido, acrescento os seguintes julgados de nossa Corte:

> Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Raimundo Nonato de Souza Braid Filho (1ª CC) 1ª CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL Nº 0104527-34.2021.8 .17.2001 APELANTE: UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO APELADO: LILIAN KELLY NEGREIROS BEZERRA RELATOR: DES. RAIMUNDO NONATO DE SOUZA BRAID FILHO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER . PARCIALMENTE PROCEDENTE. PLANO DE SAÚDE. FÁRMACO PROLIA 60MG (DENOSUMABE). OSTEOPOROSE E RAQUITISMO ADULTO . FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO DOMICILIAR. SITUAÇÃO NÃO ABARCADA PELAS DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO ANEXAS AO ROL DA ANS. COMPROVAÇÃO DA EFICÁCIA DO MEDICAMENTO . NÃO DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE TRATAMENTO SIMILARMENTE EFICAZ E SEGURO INCORPORADO AO ROL. COBERTURA OBRIGATÓRIA. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA. COMPETÊNCIA DO MÉDICO ASSISTENTE PARA INDICAR O TRATAMENTO NECESSÁRIO . SENTENÇA IRRETOCADA. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, sendo as partes acima indicadas, acordam, os Senhores Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Pernambuco acordam, por unanimidade de

votos, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, estando tudo de acordo com as notas taquigráficas, votos e demais peças que passam a integrar este julgado. Recife, data da assinatura eletrônica . Des. Raimundo Nonato de Souza Braid Filho Relator

(TJ-PE - Apelação Cível: 01045273420218172001, Relator.: AGENOR FERREIRA DE LIMA FILHO, Data de Julgamento: 22/07/2024, Gabinete do Des. Raimundo Nonato de Souza Braid Filho (1ª CC))

A05 APELAÇÃO CÍVEL Nº 0073138-31.2021.8.17 .2001 ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Cível RELATOR: Desembargador Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima JUIZ PROLATOR: Lauro Pedro dos Santos Neto – 13ª Vara Cível da Capital – Seção B APELANTE: Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco Do Brasil APELADO: Elizete Bezerra de Araujo Benjamin EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PARA OSTEOPOROSE GRAVE E OSTEOTOMIA. TERAPIA IMUNOBIOLÓGICA ENDOVENOSA OU SUBCUTÂNEA EM CLÍNICA OU HOSPITAL . SITUAÇÃO NÃO ABARCADA PELAS DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO ANEXAS AO ROL DA ANS. COMPROVAÇÃO DA EFICÁCIA DO MEDICAMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE TRATAMENTO SIMILARMENTE EFICAZ E SEGURO INCORPORADO AO ROL. COBERTURA OBRIGATÓRIA . PRECEDENTE DO STJ. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. RAZOABILIDADE DO VALOR ARBITRADO NA INSTÂNCIA INFERIOR . HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO CONTINUADO. PROVEITO ECONÔMICO IMENSURÁVEL. CRITÉRIO PARA O ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA . VALOR DA CAUSA. 1. Nos termos da resolução normativa nº 465/2021 da ANS, são permitidas as exclusões assistenciais referentes ao fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, assim considerados "aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde", com exceção dos medicamentos oncológicos e os necessários para o controle dos seus efeitos adversos, bem como os utilizados em internação domiciliar (art. 17, parágrafo único, VI) . 2. Embora a terapia imunobiológica endovenosa ou subcutânea tenha sido incorporado ao rol de procedimentos e eventos em saúde, a sua cobertura pelas operadoras de saúde, em regra, somente é obrigatória nos casos clínicos expressamente indicados nas diretrizes de utilização previstas no Anexo II da Resolução

Normativa nº 465/2021 da ANS. 3. Tendo em vista a prescrição fundamentada do médico assistente de terapia subcutânea em clínica especializada, não se mostra legítima a recusa de cobertura baseada na existência de cláusula contratual excluindo a cobertura de medicamento de uso domiciliar, notadamente porque a "terapia imunobiológica endovenosa ou subcutânea" está incluída no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde (RN 465/2021 ANS – DUT 65), e que o medicamento Prolia® (denosumabe), tem registro na ANVISA (Registro ANVISA Nº 102440013), com indicação para o tratamento da osteoporose pós-menopáusica, doença que acomete a apelada, o que evidencia que possui respaldo da comunidade científica e de órgãos públicos nacionais, havendo comprovação da sua eficácia à luz da medicina baseada em evidências . 4. A negativa de cobertura para terapia medicamentosa destinada ao tratamento da osteoporse, doença de notória gravidade, sem que a operadora de saúde informe a existência de outros exames com cobertura obrigatória similarmente eficazes e seguros capazes de atingir a finalidade pretendida, faz surgir o dano moral indenizável por potencializar a angústia experimentada pelo paciente. 5. A indenização por dano moral, fixada no valor de R$ 10 .000,00 (dez mil reais), por atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, ainda, ao caráter punitivo-pedagógico da reprimenda, deve ser mantida. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo que, quando o valor da cobertura indevidamente negada é imensurável no momento da fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, assim ocorrendo nos tratamentos continuados ou por prazo indefinido, o critério para o seu arbitramento, seguindo a ordem de preferência estabelecida pela Segunda Seção, deve ser o do valor da causa. 7 . Apelação parcialmente provida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0073138-31.2021.8 .17.2001, acordam os Desembargadores da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, na conformidade dos votos, notas taquigráficas e demais peças processuais que integram este julgado, por unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator Desembargador Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima. Recife, Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima Desembargador Relator

(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 0073138-31.2021 .8.17.2001, Relator.: FABIO EUGENIO DANTAS DE OLIVEIRA LIMA, Data de Julgamento: 31/03/2024, Gabinete do Des. Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima (1ª CC))

Por fim, no que tange a indenização por danos morais, no caso em comento, são *in re ipsa*, ante a negativa das operadoras rés em fornecerem o medicamento requerido, imprescindível para tratar a patologia da parte autora, fato que extrapola o mero aborrecimento, estando evidente o abalo à sua dignidade, traduzida nos sentimentos de angústia e sofrimento, ensejando a reparação pelo dano moral experimentado.

Assim, considerando que o dano moral, neste caso, embora não tenha como foco a honra ou imagem da vítima, decorre do mal físico que lhe foi causado, torna-se prudente convir que a situação da parte autora diante da negativa da ré não se configurou compatível com a necessidade de seu tratamento.

DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

Como sabido, o arbitramento do dano moral é fixado pelo julgador, utilizando-se, para tanto, do critério da fixação equitativa, tendo em vista a repercussão do dano, a intensidade do dolo ou culpa, bem como a possibilidade econômica das partes.

A indenização deverá ser proporcional ao dano sofrido (art. 944 do Código Civil), com as seguintes finalidades: a) compensatória à vítima pela lesão à honra e à integridade moral, não se permitindo que o dano seja fonte de lucro; b) pedagógica, com o fito de evitar que condutas abusivas sejam novamente praticadas em detrimento de outros consumidores.

Por conseguinte, em casos como tais, deve o julgador utilizar o critério da razoabilidade, aferindo as causas e consequências do ato ilícito.

Quanto aos danos materiais, penso que igualmente procedem, tendo em vista a recusa da ré em fornecer o medicamento, havendo que arcar, a parte autora, com o custeio da primeira dose do medicamento (id. 196461146).

Assim, uma vez que se encontra nos autos a prova do efetivo dano, devem os planos ressarcirem o valor gasto, com os acréscimos legais.

Face ao exposto, e atento a tudo o mais que dos autos consta, com base no art. 487, I do Código de Ritos, **JULGO PROCEDENTES** os pedidos autorais, extinguindo o feito com resolução do mérito para:

- CONFIRMAR, e tornar definitiva, a decisão que deferiu a tutela de urgência id. **196595266**, ***caso ainda não o tenha feito***, conforme prescrito em laudo médico atualizado;

REGISTRE-SE que a obrigação do réu deverá ser cumprida mediante a apresentação, *periódica*, de prescrição médica atualizada, comprovando a necessidade de continuação do uso da medicação, a fim de que seja impedido qualquer desvio de finalidade no fornecimento do fármaco em questão, protegendo a finalidade pública da presente decisão.

Ressalto que, acaso haja comprovado descumprimento da tutela de urgência outrora deferida, fica desde já autorizado o bloqueio via SISBAJUD do montante correspondente ao valor do medicamento devendo, para tanto, serem acostados dois orçamentos.

Feito o bloqueio, as partes deverão ser intimadas, e o valor transferido para a conta da empresa beneficiária, ou da autora, caso já tenha sido desembolsado o valor pela mesma.

- **CONDENAR** as Demandada, de forma solidária, consoante textualizado nos fundamentos desta decisão, a pagar à demandante, a título de compensação por danos morais, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido com base no IPCA, tendo-se por termo a quo a data da presente decisão (Enunciados das Súmulas n. 362 e 160 do STJ e do TJPE, respectivamente); cominando-se, ainda, juros de mora pela taxa Selic descontando-se a variação do IPCA e desconsiderando-se eventuais juros negativos (Lei 14.905/2024);

- CONDENAR as Demandadas, de forma solidária, no reembolso do valor gasto com o medicamento consoante nota fiscal de id. 196461146, no valor de R$ 932,54, acrescido de correção monetária desde a data do prejuízo, e juros de mora desde a citação (súmula 43 do STJ);

- CONDENAR as demandadas, solidariamente, no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, sendo que estes, por força do art. 85, §2º, I a IV, do novel Código de Processo Civil, arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, devidamente atualizado.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

No caso de interposição de recurso de apelação, intime-se a parte apelada, por intermédio de seus advogados/procuradores para, no prazo de 15 (quinze) dias (a teor do art. 1.010, §1º, do Código de Processo Civil), apresentar, querendo, contrarrazões.

Decorrido o prazo, com ou sem a apresentação da resposta, remetam-se os autos à instância superior, com as nossas homenagens, e após as baixas necessárias na Distribuição, independentemente de novo comando judicial.

Uma vez cumpridas todas as formalidades legais, remetam-se ao arquivo.

Recife- PE, data e assinatura eletrônicas.

MARCO AURÉLIO MENDONÇA DE ARAÚJO - Juiz de Direito

Assinado eletronicamente por: MARCO AURELIO MENDONCA DE ARAUJO
26/05/2025 18:26:17
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 205221300

25052618261697900000199886168

IMPRIMIR GERAR PDF